

27. 怀孕和生产：从发现怀孕到出院办证

这一节前半段算的是孕妇和胎儿的死亡风险。后半段算的是钱和跑腿时间。两种账不放在一起换算。内容只讲「什么时候做什么」。孕期营养、胎教这类没有硬证据、或者作用很小的事，这里不写。生育津贴、产假和养孩子的钱账见第 18 节，孩子出生之后怎么带见第 20 节，急症见第 13 节。

世界卫生组织给的数字：2023 年，全球约有 26 万名女性死于怀孕和生产。其中约 75% 死于这五类原因：产后大出血、感染、妊娠期高血压疾病（怀孕后血压升高的一类病，包括子痫前期和子痫）、分娩时的并发症、不安全的人工流产。世界卫生组织同时说，「大多数孕产妇死亡是可以预防的，因为预防和处理并发症的医疗手段都是已知的」。这一节里作用最大的几条，就是把这几类问题提前拦下来。

1. 准备怀孕就开始每天补 0.4 毫克叶酸，一直吃到孕早期满 3 个月

- 成本：几十元一瓶。农村妇女不用花钱，国家的免费增补叶酸项目会发。每天吃一粒，难在天天记得住
- 说人话：怀孕前后每天吃一粒叶酸，孩子出现神经管缺陷的概率大约能降七成。神经管缺陷就是无脑儿、脊柱裂这一类的出生缺陷。已经生过一个这样的孩子的人，再生一个还出问题的概率，大约降到原来的三分之一。
- 收益：Cochrane 系统综述把 5 项试验、6708 例分娩合起来一起算，证据质量评为高。怀孕前后每天补叶酸，胎儿神经管缺陷的风险 RR 0.31（95% CI 0.17 至 0.58，可信范围），约降低七成。已经生过神经管缺陷孩子的人，再生一个又出问题的风险 RR 0.34（95% CI 0.18 至 0.64），降到原来的三分之一左右。按人群分组来看，0.4 毫克和更高的剂量效果没有差别。单独吃叶酸和吃复合维生素，效果也没有差别
- 证据等级：A
- 来源：De-Regil LM, Peña-Rosas JP, Fernández-Gaxiola AC, Rayco-Solon P (2015). Effects and safety of periconceptional oral folate supplementation for preventing birth defects. Cochrane Database of Systematic Reviews, (12), CD007950. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD007950.pub3>
- 备注：关键是「怀孕前就开始吃」。胎儿的神经管在受孕后 28 天内就长合了。等你测出怀孕再吃，这段时间已经过去大半。所以打算要孩子，就提前 3 个月开始吃。同一篇汇总研究里，叶酸对唇腭裂、先天性心脏病、流产都没有明确效果，别指望它治别的

2. 孕 13 周前去社区卫生服务中心建《母子健康手册》，把免费产检额度用掉

- 成本：不花钱，这属于国家基本公共卫生服务项目。要按孕周跑几趟
- 说人话：孕期至少五次产检，加上产后上门访视和产后 42 天检查，这些钱国家出。领的办法是怀孕 13 周以前去社区建一本《母子健康手册》。不去建，这几次免费的就白白错过。
- 收益：《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》里有孕产妇健康管理服务。辖区内的常住孕产妇可以做这些。孕早期健康检查 1 次，孕中期 2 次，孕晚期 2 次，产后访视 1 次，产后 42 天健康检查 1 次。孕 13 周前要去建册，同时做第 1 次产前检查。孕中期那两次分别在孕 16 至 20 周、孕 21 至 24 周。孕晚期那两次分别在孕 28 至 36 周、孕 37 至 40 周。地方公开的服务清单里，还包含第一次的一整套化验和产后抑郁筛查
- 证据等级：A
- 来源：国家卫生计生委 (2017). 国家基本公共卫生服务规范（第三版）. <https://www.nhc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2017/04/20170417104506514.pdf>；靖江市人民政府. 国家基本公共卫生服务项目——孕产妇健康管理服务（地方服务清单公开）. https://www.jingjiang.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/wsjk/art/2023/art_383017a2e7794892bc772bfbe042f379.html
- 备注：这 5 次是免费的下限，不是产检的全部。医院会按情况加做超声、血糖、胎心监护，这些要自己掏钱。建册越早，妊娠风险分级越早做出来。妊娠风险分级就是按风险高低给孕妇分档，查出是高危的，才能早点转到接得住的医院。人住在外区的，按现在住的地方建册，不用回户籍地

3. 第一次产检就把艾滋病、梅毒、乙肝三项查掉，查出来也有免费的阻断

- 成本：不花钱，预防母婴传播项目提供免费检测
- 说人话：第一次产检就把艾滋病、梅毒、乙肝这三样查掉，检测不用自己掏钱。真查出来也不是绝路。国家免费给药、给方案，挡住病从母亲传给孩子的那条路，这叫母婴阻断。
- 收益：母婴传播就是病从母亲传给孩子。《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020 年版）》有要求。在孕早期或者第一次产前检查的时候，医院要告知相关信息，并「提供适宜、规范的免费检测」，这三项检测不用自己掏钱。再根据结果提供检测后咨询或者转诊。查出阳性也不是绝路。《艾滋病防治条例》第四十四条规定，向感染艾滋病病毒的孕产妇「免费提供预防艾滋病母婴传播的治疗和咨询」。第四十三条要求提供阻断（不让病传给孩子）、治疗、产后访视、婴儿随访和检测等服务。母亲乙肝表面抗原阳性的，新生儿出生时要同时打乙肝疫苗和乙肝免疫球蛋白（见第 20 节第 2 条）
- 证据等级：A
- 来源：国家卫生健康委办公厅 (2020). 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020 年版）. <https://wjw.xinjiang.gov.cn/hfpc/zhgl6/202012/08b7de496f0b40e586d4b99d00cf79c4.shtml>（新疆维吾尔自治区卫生健康委员会转载）；国务院 (2006). 艾滋病防治条例（第四十三、四十四条）. https://wjw.beijing.gov.cn/zwgk_20040/zcwj2022/flfg/202304/t20230408_2992986.html（北京市卫生健康委员会转载）
- 备注：这三项越早查越有用，因为阻断和治疗都需要时间。艾滋病防治条例第三条还写明「任何单位和个人不得歧视艾滋病病毒感染者、艾滋病病人及其家属」，结婚、找工作、看病、上学这些合法权益受法律保护。日常的预防和检测见第 1 节。发生高危行为之后的暴露后阻断见第 13 节

4. 整个孕期一支烟一口酒都不要，家里人也别在屋里抽

- 成本：不花钱，还能省下烟酒钱。难在让同住的人跟着一起戒
- 说人话：孕期抽烟，孩子早产、生下来太小、唇腭裂的概率都往上走。孕期和生产时异常出血的风险直接翻一倍。婴儿猝死的风险也更高。家里人在屋里抽，一样算。什么时候戒都还来得及。
- 收益：美国疾病控制与预防中心的口径：孕期吸烟会让孩子「足月出生也可能过小」「可能早产」。它会「使孕期和分娩期异常出血的风险翻倍」。它会提高唇裂、腭裂等出生缺陷的风险。它还会「损害胎儿正在发育的肺和大脑，损害可持续到儿童期」。孕期吸烟的母亲生的婴儿，以及出生后接触烟雾的婴儿，婴儿猝死综合征的风险更高。官方建议是「最好在怀孕前就戒烟，但如果已经怀孕，戒了仍然有用」「什么时候戒都不晚」
- 证据等级：A
- 来源：Centers for Disease Control and Prevention. Smoking During Pregnancy. <https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/pregnancy.html>
- 备注：别人在屋里抽，孕妇吸到的二手烟对胎儿一样算数。所以同住的家人也别在屋里抽。酒也一样：没有哪个喝酒的量是已知安全的，孕期最省事的做法就是一口不喝。烟酒对成年人自己的账见第 2 节

5. 有子痫前期高危因素的，孕 12 周后开始每天一片小剂量阿司匹林

- 成本：几十元。每天一片，要一直吃到生。难在天天不忘
- 说人话：子痫前期是孕期的一种高血压病。上一胎得过、怀多胎、有慢性高血压、孕前有糖尿病、有肾病或自身免疫病的人算高危。高危的人从孕 12 周起每天一片小剂量阿司匹林，子痫前期低约一成半，早产和孩子在生产前后死亡都低约两成。其他人别自己吃。
- 收益：美国预防服务工作组给的是 B 级推荐：对子痫前期高危的人，在孕 12 周之后开始吃小剂量阿司匹林（81 毫克/天）来预防。子痫前期是孕期的一种高血压疾病。把多项研究合起来算，结果如下，95% CI 是可信范围。子痫前期 RR 0.85（95% CI 0.75 至 0.95，16 项研究），低约 15%。早产 RR 0.80（95% CI 0.67 至 0.95，13 项研究），低约 20%。围产期死亡 RR 0.79（95% CI 0.66 至 0.96，11 项研

究)，低约 21%；围产期死亡就是生产前后这段时间里的死亡。小于胎龄儿／宫内生长受限 RR 0.82 (95% CI 0.68 至 0.99, 16 项研究)，低约 18%；说的是胎儿长得比同孕周的偏小

- 证据等级：A
- 来源：US Preventive Services Task Force (2021). Aspirin Use to Prevent Preeclampsia and Related Morbidity and Mortality: Preventive Medication. <https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/low-dose-aspirin-use-for-the-prevention-of-morbidity-and-mortality-from-preeclampsia-preventive-medication>
- 备注：算高危的有：上一胎得过子痫前期、怀的是双胞胎或者多胎、有慢性高血压。还有怀孕前就有 1 型或者 2 型糖尿病、有肾病，以及有系统性红斑狼疮、抗磷脂综合征这类自身免疫病。不在这几类里的不要自己吃。这个药要医生开处方，产检的时候把病史说清楚，让医生判断。国内卖的多是 100 毫克的肠溶片，按医嘱吃

6. 孕 24 周及以后做一次妊娠期糖尿病筛查，别嫌喝糖水麻烦

- 成本：几十到一百多元。要空腹去，抽几次血，占掉半个上午
- 说人话：妊娠期糖尿病就是怀孕之后才出现的血糖高。孕 24 周以后花半个上午，喝一次糖水、抽几次血，就能查出来。不查也不管，胎儿长得过大、难产、挨一刀、子痫前期和新生儿低血糖的风险都会往上走。
- 收益：美国预防服务工作组的 B 级推荐：对没有症状（自己没觉出不舒服）的孕妇，在孕 24 周及以后筛查妊娠期糖尿病。妊娠期糖尿病就是怀孕之后才出现的血糖高。只做一次筛查的，这一次要放在孕 24 周及以后。孕 24 周之前就筛查好不好，工作组的结论是现有证据不足以判断好处和坏处 (I 级)。妊娠期糖尿病不管，会推高这几样的风险：巨大儿（胎儿长得过大）、难产、剖宫产、子痫前期和新生儿低血糖
- 证据等级：A
- 来源：US Preventive Services Task Force (2021). Gestational Diabetes: Screening. <https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/gestational-diabetes-screening>
- 备注：查出来的人里，大多数靠调饮食和运动就能把血糖控住，需要打胰岛素的是少数。别因为怕查出来要打针，就跳过这一次。生完之后还要复查血糖：得过妊娠期糖尿病的人，以后得 2 型糖尿病的风险明显更高

7. 背下这张「立刻去医院」的清单，孕期和产后一年内都算数

- 成本：不花钱。花五分钟记住，最好也让同住的人知道
- 说人话：任何一条出现，当天就去医院，别在家等一晚。头痛不好或越来越重、看东西变样、发烧到 38℃。手或脸肿得厉害、喘不上气、胸痛或心跳快。肚子剧痛不缓解、胎动停了或明显变少、阴道出血或流液。一条胳膊或腿又肿又痛、想伤害自己或孩子。产后一年内也算。
- 收益：美国疾病控制与预防中心列出的孕产期紧急预警信号有这些：头痛一直不好或者越来越重、头晕或者晕过去、看东西变样、体温达到 38℃ 或更高；手或者脸肿得厉害、有伤害自己或者伤害孩子的念头、呼吸困难、胸痛或者心跳过快；恶心呕吐很厉害、肚子剧烈疼痛一直不缓解、孕期胎动停止或者明显减少；孕期阴道出血或者流出液体、产后阴道出血或者分泌物不正常；一条胳膊或者一条腿严重肿胀、发红或者疼痛。这些问题在产后一年内都可能发生，不是「出了月子就没事」
- 证据等级：A
- 来源：Centers for Disease Control and Prevention. Hear Her — Urgent Maternal Warning Signs. <https://www.cdc.gov/hearher/maternal-warning-signs/index.html>；World Health Organization. Maternal mortality fact sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>
- 备注：这张清单的用处，是把「再忍忍」和「必须马上走」分开。头痛加上看东西发花，再加上上腹部疼，指向的是子痫前期（孕期的高血压疾病）。一条小腿又肿又痛，指向的是深静脉血栓（见第 13 节）。产后大出血按世界卫生组织的说法，可以在几小时内夺走一个健康女性的生命。任何一条出现就直接去医院，不要先在家等一晚

8. 破水了就地平躺、垫高臀部、打 120，不要走动也不要洗澡

- 成本：不花钱
- 说人话：破水了不是慢慢收拾东西再出发。正确做法是就地躺下、把屁股垫高、打 120。站着走动，羊水流得更快，脐带可能跟着被冲下来。那是能要孩子命的急症。
- 收益：北京市卫生健康委员会给的处置办法：发现破水后「马上找个地方平躺下来，防止羊水流出」，「不要随意走动」，并且「立即拨打 120 急救电话」。等车的时候通知家里人带东西到医院会合。医疗机构的科普进一步说明了为什么：人站着的时候羊水流失更快，胎儿的脐带可能跟着掉出来，这叫脐带脱垂，是危及胎儿的急症。所以要躺下，把臀部垫高，可以取左侧卧位
- 证据等级：B
- 来源：北京市卫生健康委员会. 每周急救话题：准妈妈羊水早破怎么办？https://wjw.beijing.gov.cn/bmfw_20143/jkzs/jzjj/202001/t20200115_1575632.html；北京市顺义区妇幼保健院. 孕晚期在家破水怎么办？<https://www.bch-syfy.cn/Html/News/Articles/9453.html>
- 备注：快生的三个征兆是规律宫缩、见红、破水。前两个都可以从容收拾东西，破水是唯一一个「当场躺下叫车」的。破水后洗澡、蹲厕所、自己开车，都是典型的错误做法。记下破水的时间和羊水的颜色，告诉医生。羊水发黄绿色，或者带着胎粪颗粒，提示胎儿窘迫（胎儿在子宫里缺氧）。同时还有规律宫缩、胎动明显减少、发热打寒战的，更要跟医生强调这是急诊

9. 想要无痛分娩就直接说，它不增加剖宫产的风险

- 成本：几百到一千多元，各地价格不一样。要提前问医院和麻醉科能不能做。难在得自己开口提
- 说人话：无痛分娩就是在腰上打一针麻药，把生孩子的疼压下去。它比别的止疼办法更管用，也不会让你更可能挨一刀。「打了无痛腰疼一辈子」同样没有依据。现在它有了单独的收费项目，医院也更愿意做。
- 收益：Cochrane 系统综述的结论是：硬膜外镇痛在减轻产痛、提高产妇对镇痛的满意度上，比不用硬膜外的办法更有效。无痛分娩用的就是硬膜外镇痛。同一篇还说，「硬膜外镇痛对剖宫产风险和长期腰痛没有影响」。器械助产（用器械把孩子接出来）增加的现象，在 2005 年以后的研究中已经看不到。2024 年起，国家医保局的产科类医疗服务价格项目立项指南，把「分娩镇痛」「导乐分娩」「亲情陪产」单独立了项。理由正是原先没有独立的价格项目，医院提供分娩镇痛的积极性被压低
- 证据等级：A
- 来源：Anim-Somuah M, Smyth RMD, Cyna AM, Cuthbert A (2018). Epidural versus non-epidural or no analgesia for pain management in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews, (5), CD000331. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000331.pub4>；国家医疗保障局 (2024). 重构产科服务价格项目 助力构建生育友好型社会. https://www.gov.cn/zhengce/202406/content_6957553.htm
- 备注：「打无痛会腰疼一辈子」和「打无痛会难产要挨刀」这两条流传最广的说法都没有依据。Cochrane 把硬膜外镇痛和别的镇痛办法放在一起汇总，结论是它对剖宫产风险和长期腰痛都没有影响。真实的副作用是这些：血压偏低、发热、腿发软、尿不出来，以及第一、第二产程变长、更可能要用缩宫素。做不做自己定，但别因为传言放弃。能不能做还要看医院有没有 24 小时在场的麻醉医生，产检的时候就问清楚

10. 没有医学指征就别主动要求剖宫产，也别为了挑日子开刀

- 成本：不花钱。难在顶住家里人的说法
- 说人话：世界卫生组织的说法是，一个地方的剖宫产比例超过 10% 以后，母亲和新生儿的死亡就不再继续下降。该剖的一定要剖。为了挑日子、怕疼去剖，只是白挨一次腹部大手术。
- 收益：世界卫生组织 2015 年的声明：一个人群里的剖宫产率上升到约 10% 时，孕产妇和新生儿的死亡数会下降。超过 10% 之后，没有证据显示死亡率还能进一步改善。世界卫生组织同时强调，应当尽一切努力，为有需要的产妇提供剖宫产，而不是为了凑某个特定的比率
- 证据等级：A

- 来源：World Health Organization (2015). WHO Statement on Caesarean Section Rates (WHO/RHR/15.02) . <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-15.02>
- 备注：医学上确实需要的时候，剖宫产是救命手术，该做就做，别硬扛。要避免的是医学上并不需要还去开刀，比如怕疼、挑吉时、算孩子上学的年龄。剖宫产是腹部大手术，恢复更慢，下一胎出现前置胎盘、胎盘植入和子宫破裂的风险更高。这直接影响你还想不想生第二个

11. 怀孕前就确认生育保险的参保状态，未就业的配偶也能报生育医疗费用

- 成本：不花钱。打一次社保或者医保的咨询电话
- 说人话：单位交了生育保险，生孩子的医疗费和产假期间的津贴都从这笔基金里出。配偶没工作的，医疗费这一块也能报。参保月数够不够、在外地生要不要先备案，都得提前问，事后补不了。
- 收益：《社会保险法》第五十四条：用人单位已经缴纳生育保险费的，其职工享受生育保险待遇。职工没有工作的配偶，按照国家规定享受生育医疗费用待遇，所需资金从生育保险基金中支付。说白了，单位交了生育保险，职工本人能享受待遇，职工那位没工作的配偶生孩子的医疗费，也能从这笔基金里出。生育保险待遇分两块：一块是生育医疗费用，就是生孩子这件事本身的医疗费；另一块是生育津贴，就是产假期间发给你那笔钱。第五十六条列明了能领生育津贴的三种情形：女职工生育享受产假、享受计划生育手术休假、法律法规规定的其他情形。生育津贴「按照职工所在用人单位上年度职工月平均工资计发」，算的是你所在单位去年的职工月平均工资，不是你自己的工资
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2010). 中华人民共和国社会保险法（第五十四、五十六条）. https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/qysw_gkwj/2020-02/12/content_8e8c485d0db34b989531f3ba57cec5a9.shtml（国家税务总局广东省税务局转载）
- 备注：两件事要提前问清楚，因为事后补不了。一是连续参保的月数够不够：各地都定了最低月数，不够就享受不了。二是不在参保地生的，要不要先办异地生育备案：没备案的可能只能自己先垫钱，回来再手工报销，甚至报不了。产假天数和生育津贴怎么算见第 18 节第 2 条

12. 出院前把《出生医学证明》办掉，名字提前想好、别写错字

- 成本：不花钱。办出院手续的时候顺手就办了
- 说人话：这张证是上户口、参保、上学的前置件，而且只有接生的那家机构能第一次开。出了院再回头补，要另走一套流程、多交材料。名字里的字，先确认户籍系统打得出来。
- 收益：《母婴保健法》第二十三条：医疗保健机构和从事家庭接生的人员，按照国务院卫生行政部门的规定，出具统一制发的新生儿出生医学证明。这张证是后面所有事的前置条件：上户口、参保、办医保卡、入园入学都要它。而且第一次签发只能由接生的机构办。出了院再回头补办，要走另一套流程，还需要额外的证明材料
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (1994, 2017 修正). 中华人民共和国母婴保健法（第二十三条）. https://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647619.htm
- 备注：填之前把父母姓名、身份证号和孩子姓名逐字核对一遍。姓名用字要能在户籍系统里打得出来，生僻字以后办事会很麻烦。改名和改证都要走补发或者换发，比当场核对麻烦得多。证拿到手就单独收好，和户口本、身份证一样要紧

13. 新生儿足跟血筛查和听力筛查都别拒绝

- 成本：多数地区免费，或者几十元。有些扩展项目要自己掏钱。孩子出生后扎一次足跟
- 说人话：扎一次足跟血、做一次听力测试，能在孩子看起来完全正常的时候，查出甲减、苯丙酮尿症和听力障碍。等症状显出来，智力上的损害已经补不回来了。
- 收益：《新生儿疾病筛查管理办法》第三条：「全国新生儿疾病筛查病种包括先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症等新生儿遗传代谢病和听力障碍。」这两类病有个共同点：早期完全看不出异常，

等到症状明显的时候，智力损害已经不可逆了。而早发现早干预效果很好，办法是补充甲状腺素、喝特殊配方奶、戴助听器或者装人工耳蜗。第十条规定，筛查结果是阳性的，机构应当及时通知监护人去确诊

- 证据等级：A
- 来源：卫生部 (2009). 新生儿疾病筛查管理办法（卫生部令第 64 号，第三、十、十一条）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2009/content_1371363.htm
- 备注：办法第十一条要求，筛查前要把项目、条件、方式、灵敏度（能查出多少）和费用如实告诉监护人，并签字同意。所以你会拿到一张知情同意书。签之前看清楚：哪些是国家规定的病种，哪些是自费的加项。初筛阳性不等于确诊，绝大多数复查一次就排除了，别在这一步先崩溃。听力初筛没过的要按通知去复筛，别自己判断「孩子听得见就算了」

14. 拿到出生医学证明就给孩子办居民医保，别等落完户

- 成本：一年交一次居民医保保费，几百元
- 说人话：拿到出生证就能在网上给孩子参保，不用等落户。参上了，出院时的住院费当场就能报。新生儿的住院费不低，参保和没参保差别很大。
- 收益：中国政府网 2024 年的口径：「新生儿凭出生医学证明就可以在线上参保」，不必先落户。「新生儿出院以后就能够直接报销医药费用」。以前的做法是落了户才能参保，住院费得先全额垫付，再回头报销。参保缴费的平均办理时长，也从年初的 28.7 个工作日压减到 6.4 个工作日
- 证据等级：A
- 来源：中国政府网 (2024). 健全基本医疗保险参保长效机制国务院政策例行吹风会. https://www.gov.cn/zhengce/202409/content_6973567.htm
- 备注：早产、黄疸照蓝光、新生儿肺炎，这些是新生儿住院的常见原因，动辄上万元，参保和不参保差别很大。各地对「出生后多少天内参保，可以从出生那天起享受待遇」的规定不完全一样。具体怎么执行，以当地医保部门说的为准。出院前打 12393 问一句最省事

15. 孩子出生后一个月以内去派出所申报出生登记

- 成本：不花钱。跑一趟派出所的户籍窗口
- 说人话：法律给的是一个半月，不是「有空再说」。落户卡着后面的打疫苗、入园、入学和办身份证。越往后拖，要补的材料越多。
- 收益：《户口登记条例》第七条：「婴儿出生后一个月以内，由户主、亲属、抚养人或者邻居向婴儿常住地户口登记机关申报出生登记。」这是法律定的时限，不是建议。落户是后面这些事的前置条件：打疫苗、入园、入学、办身份证。越往后拖，需要补的材料越多
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (1958). 中华人民共和国户口登记条例（第七条）. http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/zcfgk/content/post_2531969.html（广东省人民政府转载）
- 备注：带齐这些：出生医学证明、父母双方的身份证和户口本、结婚证。跟父亲落户还是跟母亲落户可以自己选，但两个地方的政策不一样，学区和参保地都受影响。去之前想清楚，改起来麻烦。没结婚生的孩子，同样可以申报出生登记

16. 产后 42 天那次复查别跳过，它同时是产后抑郁的筛查

- 成本：不花钱，属于基本公共卫生服务。占半天时间。难在刚出月子懒得动
- 说人话：这次复查不花钱，含血常规、白带常规，还包含一次产后抑郁筛查。产后一年内都可能出大问题，别觉得出了月子就安全了。
- 收益：《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的孕产妇健康管理里，产后有 1 次产后访视和 1 次产后 42 天健康检查。地方公开的服务清单里，这一次含化验（血常规、白带常规）和 1 次产后抑郁筛查。产后一年内都可能出现严重并发症。第 7 条那张「立刻去医院」的清单里，「有伤害自己或伤害孩子的念头」「产后阴道出血或异常分泌物」「一侧肢体严重肿痛」都属于产后

- 证据等级：A
- 来源：国家卫生计生委 (2017). 国家基本公共卫生服务规范（第三版）. <https://www.nhc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2017/04/20170417104506514.pdf>；靖江市人民政府. 国家基本公共卫生服务项目——孕产妇健康管理服务（地方服务清单公开）. https://www.jingjiang.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/wsjk/art/2023/art_383017a2e7794892bc772bfbe042f379.html
- 备注：产后抑郁不是矫情，靠家里人劝一句「想开点」也解决不了。它有专门的筛查问卷，有治疗，可以恢复。有自杀念头时的处置见第 1 节。孩子生下来确实养不了时的合法出路见第 9 节第 20 条。这次复查还会看伤口长得怎么样、子宫恢复得怎么样、盆底功能好不好。避孕方案也在这次谈：产后不来月经，不等于不会怀孕

28. 别为了外形把身体搞坏

本节说的是「为了改变外形而对身体动手」的几种做法：饿肚子、吃药、打针、开刀。这几件事，决定多半是和别人比较之后做的，代价却全落在自己身上，而且相当一部分改不回来。

本节不评价任何人想把自己变成什么样子，那是各人自己的事。同一个目标，可以找「有处方、有资质、有复查」的，也可以「网购、美容院、自己加量」，本节只比这两种做法的风险差多少。算账主要看身体上实际出了什么事，比如失明、住院、死亡。医美那两条还涉及非法行医的刑事责任。

1. 不要用极端节食、断食或催吐来控制体重，要减就从运动那一侧减

- 成本：不花钱。反过来还省下买减肥产品的钱。
- 说人话：神经性厌食的人，死亡概率大约是同龄人的 5.9 倍。每 1000 个人跟一年，死 5.1 个。死的人里每五个有一个是自杀。而它的入口就是节食：跟踪 44 所中学的学生三年，严重节食的女生出现进食障碍的概率是不节食的 18 倍。想控制体重就多运动，别少吃到饿。
- 收益：36 项研究合起来算。神经性厌食这一批人累计被跟踪了 166,642 人年（每人被跟踪的年数加总）。他们的标准化死亡比是 5.86，即死亡概率约为同龄人的 5.9 倍。每 1000 人年死亡 5.1 例，就是 1000 个人跟一年死 5.1 个。死的人里约 1/5 死于自杀。贪食症的标准化死亡比是 1.93，其他进食障碍是 1.92，即各约为同龄人的 1.9 倍。另一项研究在澳大利亚维多利亚州的 44 所中学做，跟踪 14–15 岁学生 3 年、同一批学生三年里前后查了 6 波。女生新发进食障碍 21.8/1000 人年，即 1000 个女生跟一年新出 21.8 例。严重节食的女生发病风险是不节食者的 18 倍，中度节食者是 5 倍。再校正既往节食与精神症状，把「以前就节食过」和「本来就有精神症状」的影响扣掉。扣掉之后，BMI（体重除以身高平方算出的胖瘦指标）、运动量和性别都不再预测新发进食障碍。作者结论是「在青少年中用运动而非限食控制体重，发生进食障碍的风险似乎更低」
- 证据等级：A
- 来源：Arcelus J et al. (2011). Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders. A meta-analysis of 36 studies. Arch Gen Psychiatry. <https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2011.74>;
Patton GC et al. (1999). Onset of adolescent eating disorders: population based cohort study over 3 years. BMJ. <https://doi.org/10.1136/bmj.318.7186.765>
- 备注：这里说的「严重节食」，指的是长期把吃的压到远低于身体需要，不是指少吃一顿或者不吃夜宵。已经出现催吐、暴食之后自责、反复称重停不下来的，去精神科或者综合医院的临床心理科看。这是有规范治疗办法的病，不是意志力的问题。BMI 与死亡率的关系见第 2 节第 32 条，那条讲长期体重区间，不讲减重手段。

2. 打针、埋线、开刀之前查两样：机构许可证上有没有「医疗美容」，动手的人是不是主诊医师

- 成本：不花钱。查这两张证只要几分钟。机构应该把《医疗机构执业许可证》挂在大厅里。医生的资质可以在卫健部门的执业医师查询里核对。
- 说人话：动针、动刀、用医疗器械，会破皮或进到身体里的，就算看病。只能在许可证上写了「医疗美容」的机构做，动手的必须是注册过的执业医师。在美容院、工作室、酒店房间里做属于非法行医。动手的人情节严重判 3 年以下，伤了人判 3 到 10 年，致人死亡判 10 年以上。
- 收益：《医疗美容服务管理办法》第二条给医疗美容下了定义。原文是「运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑」。说白了，只要破皮、进针、进到身体里，就按看病算。第八条和第二十四条要求先取得《医疗机构执业许可证》，并经登记机关核准医疗美容诊疗科目，才能开展。许可证上没写「医疗美容」这一项，就不能做。第十一条要求主诊医师（动手的那位医生）具有执业医师资格并且注册过。做美容外科的还要有 6 年以上相关专业临床工作经历，美容牙科 5 年以上，美容中医科与美容皮肤科各 3 年以上。第二十条要求动手之前书面告知适应症、禁忌症（什么情况适合做、什么情况不能做）、医疗风险和注意事项，并取得签字同意。《刑法》第三百三十六条管的是非法行医。非法行医

就是没有医生执业资格的人给人打针、动刀、看病。情节严重的，处 3 年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。严重损害就诊人身体健康的，处 3 年以上 10 年以下有期徒刑并处罚金。造成就诊人死亡的，处 10 年以上有期徒刑并处罚金

- 证据等级：A
- 来源：卫生部 (2002). 医疗美容服务管理办法（卫生部令第 19 号，第二条、第八条、第十一条、第十六条、第二十条、第二十四条）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content_62198.htm；全国人大 (1997). 刑法（第三百三十六条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml
- 备注：同一份办法第十六条还规定，医美项目只能在美容医疗机构里做，或者在设有医疗美容科的医院、诊所里做。所以上门打针、在工作室里私下操作，光看地点就已经不合规。第二十条写明，未成年人这类还不能自己作主的人要做医美，必须经监护人同意，要家长签字。做脸、按摩、美甲属于生活美容，不归这套规矩管。但只要动到针和刀，就算医疗美容。

3. 面部填充避开鼻背、眉间、额头这几个部位，更别为省钱找非正规注射

- 成本：不花钱。只是换个部位打，或者不做。
- 说人话：打填充针后失明的人里，一半多打的是鼻部，其次是眉间、额头和法令纹，八成多用的是玻尿酸。失明的人只有两成视力完全恢复，一成多部分恢复，将近两成还伤到了脑。目前有一种抢救办法稳定管用，只能事先避开这些部位。
- 收益：把全世界期刊报过的病例汇总起来算。2015 年 1 月到 2018 年 9 月新增 48 例注射填充后部分或完全视力丧失。出事最多的部位是鼻部，占 56.3%。接下来是眉间 27.1%、前额 18.8%、鼻唇沟（法令纹那道沟）14.6%。81.3% 的病例填充物为透明质酸，就是玻尿酸。43.8% 出现皮肤改变。18.8% 出现中枢神经系统并发症（脑出了问题）。10 例（20.8%）视力完全恢复，8 例（16.7%）部分恢复，剩下的没恢复。作者结论为各家的处理方式差得很远，没有一种治疗被证明能持续奏效
- 证据等级：B
- 来源：Beleznay K et al. (2019). Update on Avoiding and Treating Blindness From Fillers: A Recent Review of the World Literature. *Aesthet Surg J*. <https://doi.org/10.1093/asj/sjz053>
- 备注：这些数字是把期刊报过的病例一例一例数出来的。里面只有出事的人数，没有打针的总人数。所以算不出「打一针有多大概率失明」，只看得出哪些部位出事多、事后基本救不回来。证据记 B 级也是因为这个。正规机构降低风险的做法本来就是常规：先查清要打的地方底下血管怎么走，用钝头针不用尖针，边退针边少量推，事先备好透明质酸酶。每一样都要求动手的是受过训练的医生，这也是别找非正规渠道的理由。做之前先按本节第 2 条（查机构许可证和主诊医师）核一遍。

4. 不要买承诺「快速瘦」的减肥药、减肥咖啡、瘦身糖果和酵素梅

- 成本：不花钱。反过来还省下买这些产品的钱。难的是要接受没有「一周掉几斤」这回事。
- 说人话：这类产品里最常查出偷加的是西布曲明，它原来是减肥药，2010 年在中国被停掉了。有心脏病或糖尿病的超重的人吃了三年多，没致命的心梗高约三成，中风高约三成六。体重只多减了 1.7 公斤。抽检查出来的时候，你已经吃下去了。
- 收益：SCOUT 试验招了 9,804 人。他们都是 55 岁以上、超重或肥胖，并且有心血管病或 2 型糖尿病。这些人抽签分成吃药和不吃药两组，平均治疗 3.4 年。主要终点是事先定好要数的几件坏事：非致死性心梗、非致死性卒中（中风）、心脏骤停后被救回来、心血管死亡。这几件事的发生率是 11.4% vs 10.0%。HR 1.16（95% CI 1.03–1.31, P=0.02），吃药的人出事概率高约一成六。真实值大致落在高 3% 到高 31% 之间。非致死性心梗 4.1% vs 3.2%，HR 1.28（1.04–1.57），高约三成。非致死性卒中 2.6% vs 1.9%，HR 1.36（1.04–1.77），高约三成六。心血管死亡与全因死亡未增加，全因就是各种原因加起来。抽签之后，西布曲明组平均多减重 1.7 kg。原国家食品药品监督管理局根据安全性评估认为「减肥治疗的风险大于效益」，2010 年 10 月通知停止西布曲明制剂及原料药的生产、销售、使用。西布曲明与酚酞均禁止添加于食品，保健食品也算在内
- 证据等级：A

- 来源：James WPT et al. (2010). Effect of sibutramine on cardiovascular outcomes in overweight and obese subjects. NEJM. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1003114>; 天津市市场监督管理委员会. 警惕部分食品中违法添加「盐酸西布曲明」和「酚酞」. https://scjg.tj.gov.cn/tjsscjdglwyh_52651/hdpt/cjwtyxfts/202007/t20200720_2972549.html
- 备注：SCOUT 招的是本来就有心脏病或者糖尿病的高危人群。这个试验没有证明健康年轻人吃了也一样出事。但正因为分不清谁是高危，监管才干脆让它退市。另一种常被偷加的成分是酚酞，它本来是泻药，长期吃多了会打乱体内电解质、诱发心律失常。怎么判断：正经减肥药是处方药，在药店和医院能查到批准文号。打着「咖啡」「糖果」「梅子」「代餐」旗号卖、又承诺一周掉几斤的，按定义就不该有药效，有药效就说明加了东西。国食药监办〔2010〕432 号的原文在国家药监局网站，本机打开一直报 412 错误，所以改引省级监管部门的转述页。「风险大于效益」和「2010 年 10 月停止生产销售使用」两句可以在那里逐字核对。

5. 不要用合成代谢类固醇（「增肌针」「口服药」）来长肌肉

- 成本：不花钱，还省下药钱。难的是要接受肌肉长得慢。
- 说人话：健身房兴奋剂检测阳性的男性，死亡风险是同龄人的 3 倍，每年跑医院的次数多一倍多。痤疮、男性乳房发育、勃起功能障碍，每十个用药的人里至少一个中招。这类药在中国是处方药，能卖给你的渠道本身就在违法。
- 收益：丹麦回头翻档案，给每个用药的人配同龄对照。用药的是 2006-01-03 至 2018-03-01 健身房兴奋剂检测雄激素类固醇阳性的 545 名男性，配了 5,450 名对照。另外又用 644 名拒绝受检者和 6,440 名对照复核了一遍。结果：使用者死亡率为对照的 3 倍，HR 3.0 (95% CI 1.3-7.0)，真实倍数大致在 1.3 到 7 之间。每年住院或就诊次数的中位数是 0.81 次 vs 0.36 次 ($P < 0.0001$)。中位数就是一半人多于、一半人少于这个数。这个 P 值说明这个差别几乎不可能是碰巧。痤疮（长痘）、男性乳房发育、勃起功能障碍各影响超过 10% 的使用者，即每十个用药的人里至少一个中招，都明显高于对照 ($P < 0.0001$)。复核的那一批结果一致。《反兴奋剂条例》第七条：国家对兴奋剂目录所列禁用物质实行严格管理，任何单位和个人不得非法生产、销售、进出口。同一条例规定蛋白同化制剂、肽类激素实行处方药管理，即只能凭医生处方买，蛋白同化制剂是法规里对这类药的叫法
- 证据等级：A
- 来源：Horwitz H et al. (2019). Health consequences of androgenic anabolic steroid use. J Intern Med. <https://doi.org/10.1111/joim.12850>; 国务院 (2004). 反兴奋剂条例（国务院令第 398 号，第七条、第九条）. http://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_63129.htm
- 备注：争议：这是跟踪一群人看结果的研究，不是随机分组试验。用药的人本身可能在别的方面也更冒险，3 倍这个数不能全记到药头上。真实倍数可能低到 1.3，也可能高到 7.0，范围很宽。但「痤疮、男性乳房发育、勃起功能障碍各有一成以上的人中招」是眼睛能看见的副作用，受这种偏差影响较小。这类药在法规里写作「蛋白同化制剂」，看到这四个字说的就是它。普通蛋白粉、肌酸不在本条之内。麻烦的是「宣称增肌特别快」的产品可能偷加成分。判断方法和减肥产品那条一样（第 4 条，不买承诺快速瘦的减肥药）：正经药是处方药、有批准文号可查。靠「增肌粉」「营养品」名义卖、又承诺几周见效的，真有效就是加了东西。

6. 要吃减肥药就去医院拿处方，别在不用处方就发货的网店买

- 成本：一次挂号，加上来回跑一趟。几十元，半天时间。
- 说人话：处方药必须凭处方卖，网上卖也必须有真实处方并且实名。不问诊、不要处方、下单就发货的，要么卖的不是它说的药，要么这家店在违规。出了事，没人替你的剂量和禁忌负责。挂一次号几十块钱，就有医生替你把这一关。
- 收益：《药品经营和使用质量监督管理办法》规定，药品零售企业要遵守处方药与非处方药分类管理制度。这个制度就是把药分成两类，一类必须凭医生处方买，一类可以自己买。药店要按规定凭处方销售处方药，处方保留不少于五年。药师或者其他药学技术人员不在岗时应挂牌告知，没经过他们审核不得销售处方药。处方药不得开架销售，不能摆在货架上由顾客自己拿。《药品网络销售

《网络销售药品监督管理办法》第九条规定，通过网络向个人销售处方药的，应当确保处方来源真实、可靠并实行实名制。第十条要求在每个药品展示页面下突出显示风险警示信息。通过处方审核前，不得展示说明书，也不得提供购买服务，处方没审过，页面上连买的按钮都不该给。第八条规定，国家实行特殊管理的药品不得在网络上销售。这类药包括疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品

- 证据等级：B
- 来源：国家市场监督管理总局 (2023). 药品经营和使用质量监督管理办法（总局令第 84 号）. https://www.gov.cn/gongbao/2023/issue_10846/202311/content_6917322.html；国家市场监督管理总局 (2022). 药品网络销售监督管理办法（总局令第 58 号，第八条至第十条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5717002.htm
- 备注：法条可以逐字核对，但「按处方吃比自己买着吃能少出多少事」没人做过量化研究，所以按「难以量化」记 B 级。本节第 5、7 条说的类固醇和性激素，也走同一套规则。真到了该靠药减重的程度，医生会先看体重指数、身上有没有别的病、有没有不能用药的情况，再定吃不吃、吃哪种。这个判断是买不到的。

7. 性激素类药只在医生开方并定期复查的前提下用，不要网购、不要自己加量

- 成本：定期挂号，加上抽血复查。一年几百元，占掉几个半天。
- 说人话：这条不讨论该不该用，只讨论怎么用。用雌激素的跨性别女性，血管里长血块的比同龄人明显多，每一千人两年多出约 4 个，八年多出约 17 个。这类风险得靠定期复查盯着，网购药、自己调量就没人替你查。
- 收益：研究者从 Kaiser Permanente 这家医疗集团的电子病历里跟踪了一批人。其中 2,842 名跨性别女性、2,118 名跨性别男性。平均跟踪 4.0 年与 3.6 年。每个人都按出生年、种族、就诊点和入组时间配了约 10 倍的顺性别对照，一共 48,686 名顺性别男性与 48,775 名顺性别女性。跨性别女性的静脉血栓栓塞（血管里长血块堵住）比对照多。和顺性别男性比，2 年是每 1000 人 4.1 例（95% CI 1.6–6.7）。8 年是 16.7 例（6.4–27.5）。算下来，1000 个人里两年多出 4.1 例，八年多出 16.7 例。和顺性别女性比，这两个数是 3.4（1.1–5.6）与 13.7（4.1–22.7）。缺血性卒中（血管堵住那一类中风）与心肌梗死总体各组接近。但在跟踪期内才开始激素治疗的跨性别女性中，静脉血栓与缺血性卒中的差异更明显。跨性别男性的证据不够，下不了结论。作者结论为「这些结果可能提示需要长期警惕跨性别激素中雌激素的血管副作用」
- 证据等级：A
- 来源：Getahun D et al. (2018). Cross-sex Hormones and Acute Cardiovascular Events in Transgender Persons: A Cohort Study. *Ann Intern Med*. <https://doi.org/10.7326/M17-2785>；国家市场监督管理总局 (2022). 药品网络销售监督管理办法（总局令第 58 号，第九条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5717002.htm
- 备注：研究者自己写明了这项研究的短处：有多少人是医院系统外自己买的药，他们查不到，所以「有没有用药」这条线本来就划不干净。所以用药更该放进正规随访里。这项研究看的只是血管出没出事，不回答激素治疗该不该用、用了有什么好处，那是另一套证据。所有用到性激素的场合都一样，包括避孕药、更年期激素治疗、睾酮补充。凡是自己网购、照着网帖调量、从不查血栓和肝肾指标的，风险都出在「没人盯着」这一段，和为什么用药无关。国内的正规路子去正规医疗机构的内分泌科或者相应专科，做评估、开方、复查。

8. 如果「觉得自己丑」已经到反复照镜子、反复想改的程度，先做一次体像评估再谈手术

- 成本：去精神科或者临床心理科挂一次号，几十元。难的是在约手术之前先去这一趟。
- 说人话：去做整形手术的人里约 15% 有躯体变形障碍，就是把别人基本看不出的缺陷放大到影响生活。去皮肤科求美的人里约 13%，两边都是七成多为女性。这种人做完一处又会盯上下一处，手术解决不了。先挂一次号看看自己是不是这种情况，再决定动不动手术。

- 收益：按规矩把 33 项研究找齐再合起来算。整形外科就诊者中，躯体变形障碍（把别人基本看不出的缺陷放大到影响生活）患病率 15.04%，各项研究在 2.21%–56.67% 之间。换成人数，每 100 个去做整形的人里约 15 个符合，单看各项研究则从 2 个到 57 个不等。这批人平均年龄 34.54 ± 12.41 岁，后一个数是上下浮动的幅度，74.38% 为女性。皮肤科就诊者是 12.65%，各项研究在 4.52%–35.16% 之间，平均年龄 27.79 ± 9.03 岁，76.09% 为女性。作者建议整形外科医师与皮肤科医师主动评估、把高风险的人认出来，并安排几个科室一起管
- 证据等级：B
- 来源：Ribeiro RVE (2017). Prevalence of Body Dysmorphic Disorder in Plastic Surgery and Dermatology Patients: A Systematic Review with Meta-Analysis. *Aesthetic Plast Surg*. <https://doi.org/10.1007/s00266-017-0869-0>
- 备注：各项研究测出来的比例从 2.21% 一直到 56.67%，差得极大。原因是用的问卷和调查的人群都不一样。所以只能读出「这个比例不低、值得先筛一次」，不能把 15.04% 当准确数字，记 B 级也是因为这个。想做医美的人绝大多数没有心理问题。本条针对的是「反复、持续、已经影响到工作和社交」这一小部分人，手术解决不了他们的问题。判断线索有这几条：一天里花很长时间检查或者遮挡某个部位，因此回避社交或者拍照，做完一处又盯上下一处。

9. 矫正牙齿要找有正畸资质的医生当面检查、按时复诊，别网购牙套自己在家戴

- 成本：比网购多出挂号和复诊的钱，每隔一段时间要去一趟诊所。难在疗程常常一两年，要坚持复诊。
- 说人话：透明牙套在国内是二类医疗器械，说明书要求在有正畸资质的医生指导下戴、定期复诊。美国药监部门说没批准过不经牙医开方就直接卖给个人的牙套。没人当面检查，可能咬合变歪、牙齿移错位置、疼痛，甚至掉牙。
- 收益：国家药监局医疗器械技术审评中心 2022 年的《无托槽矫治器注册审查指导原则》说，这种牙套「管理类别为 II 类」。它要求说明书写明「治疗过程中需在具有口腔正畸专业资质医师的指导下进行佩戴」，还要写「进食、刷牙及定期复诊的要求」。产品名称「不建议含有“隐形”等虚无、假设的概念性名称」。美国食品药品监督管理局（FDA）的说法是：「The FDA has not authorized clear aligners that are sold directly to consumers without a prescription and supervision by a dentist or orthodontist」，意思是不经牙医开方和监督、直接卖给个人的透明牙套，它一个都没批准过。FDA 还说：「In-person examination by a dentist or orthodontist can help lower the risks of uneven bite, unintended tooth movement, pain, and tooth loss」，也就是牙医当面检查能降低咬合不齐、牙齿移位、疼痛和掉牙的风险。开始戴以后定期当面复诊，才能确认牙在按计划安全移动。这两份都是监管文件，没有给出出事的比例
- 证据等级：C
- 来源：国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心 (2022). 无托槽矫治器注册审查指导原则（2022 年第 41 号）. <https://www.cmde.org.cn/flfg/zdyz/zdyzwbk/20230103095116100.html>；国家卫生健康委办公厅等 (2023). 关于进一步推进口腔医疗服务和保障管理工作的通知（国卫办医政发〔2023〕11 号，第五条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202309/content_6903786.htm；U.S. Food and Drug Administration (2026). Clear Dental Aligners（页面 2026 年 9 月 9 日更新）. <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/clear-dental-aligners>
- 备注：收益量级定为小，因为没找到出事比例，只能凭后果判断。国内药监和卫健部门针对「网购牙套在家自己戴」的风险提示没有找到，所以本条主要靠注册要求和 FDA 的说法。正畸属于医疗行为，做医疗美容性质的牙齿矫正，机构许可证要有对应科目，动手的医生要有资质，查法见本节第 2 条（机构许可证、主诊医师）。四部门 2023 年的口腔医疗通知也点名要严惩无证机构和聘用非卫生技术人员看牙。正畸医保不报，见第 24 节第 12 条（种牙之前先问清包干价）

29. 遭遇重大打击之后

亲人去世、被告知重病、失业、离婚。这几件事在研究里有个共同点：出事的不只是心情，还有身体。风险最高的那一段，集中在头几周到头一年。这一节不讲怎么「走出来」，只讲这段时间里哪些事必须有人盯住，哪些决定必须往后放，什么时候该去挂号。多数条目算的是死亡概率。谈花钱和待遇的四条算的是钱：别一上来就花钱做哀伤咨询（第 9 条）、打 12356 和挂心理门诊（第 11 条）、不可逆的大决定往后推（第 12 条）、别拿死当还债的办法（第 13 条）。两类数字不互相换算。没有亲人也没有朋友可找的，「找个人盯住」这句话怎么落地见第 6 条。

亲人去世当时的手续、遗体 and 该取的钱见第 25 节。老人生前的监护与遗嘱见第 17 节。失业能领什么见第 7 节。情绪低落时的运动与光照见第 3 节和第 22 节。有自杀念头时先打 12356 见第 1 节第 25 条、念头的时度见第 1 节第 32 条、救回来之后的后遗症见第 1 节第 33 条。这些本节都不重复。

1. 亲人刚走的那几天别一个人待着，有心脏病、高血压、糖尿病的照常吃药，胸口压着疼就叫 120

- 成本：不花钱。这几天别一个人待着，药照常吃。
- 说人话：亲人去世后头一天，心梗发作的概率是平时的 21.1 倍，之后一天比一天低。60 到 89 岁的人在伴侣去世后 30 天内，心梗或中风的比例大约翻倍，一个月后回落。本来就有心血管病的人，这几天别停药。胸口压着疼、喘不上气、一侧手脚没力，立刻打 120。
- 收益：1985 名急性心梗患者，拿同一个人发病前后的不同时间段自己跟自己比。其中 270 人（13.6%）在发病前 6 个月内失去过重要的人，19 人是在心梗前 1 天内失去的。重要的人去世后 24 小时内，急性心梗发作率升高 21.1 倍（95% CI 13.1–34.1，真实倍数大致在 13 到 34 之间）。此后逐日下降。换成实际人数：十年心梗风险 5% 的人里，每 1394 个刚失去亲人的多出 1 例。风险 20% 的人里，每 320 个多出 1 例。英国另一项研究，比了 30447 名 60 至 89 岁丧偶者和 83588 名条件相当的对照。丧偶后 30 天内发生心梗或中风的，丧偶的一边 50 人（0.16%）。对照的一边 67 人（0.08%）。IRR 2.20（1.52–3.15），即出事的概率约为对照的 2.2 倍。其中心梗 2.14（1.20–3.81），约 2.1 倍。中风 2.40（1.22–4.71），约 2.4 倍。30 天以后减弱。90 天内还看了两类病。一类是非心梗急性冠脉综合征（心脏供血急性出问题、但还够不上心梗的那类），IRR 2.20（1.12–4.29）。一类是肺栓塞（血块堵在肺的血管里），IRR 2.37（1.18–4.75）
- 证据等级：A
- 来源：Mostofsky E, et al. (2012). Risk of acute myocardial infarction after the death of a significant person in one's life: the Determinants of Myocardial Infarction Onset Study. *Circulation*. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.111.061770>; Carey IM, et al. (2014). Increased risk of acute cardiovascular events after partner bereavement: a matched cohort study. *JAMA Internal Medicine*. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2013.14558>
- 备注：药盒交给别人管，别靠自己记。这几天别开长途。别靠喝酒扛过去，酒的账见第 2 节。心梗、中风怎么认、怎么叫车见第 13 节。两项都是回头翻人群数据的研究，分不清里面有多少人本来就要发病。但两项指的方向和时间段一致。没有人可以把药盒交出去、这几天注定一个人在屋里的，见本节第 6 条。

2. 被告知重病诊断的那一周，别一个人去拿报告，治疗以外的决定往后放

- 成本：不花钱。找个人陪你去拿报告。把治疗以外的大决定推后几天。
- 说人话：拿到癌症诊断的第一周，自杀的概率是没确诊的人的 12.6 倍，死于心血管病的概率是 5.6 倍。到第一年，自杀风险降到 3.1 倍，越难治的癌越明显。所以拿报告那天带个人去，回家别一个人待着。辞职、卖房这类事，留到下次门诊再说。
- 收益：瑞典全国档案跟踪 607 万多人（6,073,240 人），时间是 1991 至 2006 年。和没确诊癌症的人相比，确诊后第一周自杀相对风险 12.6（95% CI 8.6–17.8），即约 12.6 倍。真实倍数大致在 8.6 到 17.8 之间。这一周的发病率是 2.50/1000 人年，也就是 1000 人跟一年出 2.5 例。到第一年降到 3.1（2.7–

3.5, 0.60/1000 人年), 约 3.1 倍。心血管死亡第一周 5.6 (5.2–5.9, 116.80/1000 人年), 约 5.6 倍。前 4 周 3.3 (3.1–3.4, 65.81/1000 人年)。风险升高在确诊后第一年内迅速回落。越是治起来难、活下来概率低的癌种, 升得越明显。把同一批患者不同时间段自己跟自己比, 结论一致

- 证据等级: A
- 来源: Fang F, et al. (2012). Suicide and cardiovascular death after a cancer diagnosis. *New England Journal of Medicine*. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1110307>
- 备注: 这是癌症病人的数据。换到别的重大诊断, 没有同等分量的原文。出事的人其实很少: 第一周自杀率 2.50/1000 人年, 即 1000 人跟一年出 2.5 例。写出来不是吓人, 是说明「刚知道的那几天」要有人在旁边。确诊后的长期管理、报销和复查见第 16 节和第 24 节。找不到人陪着去的见本节第 6 条 (把「那个人」换成邻居和社区名单)。

3. 失业之后先把作息、医保和找工作的节奏固定下来, 别整天待在家里

- 成本: 不花钱。先去办失业登记、领失业保险金, 再把找工作排成固定日程。难在没人催你的时候还要按点起床。
- 说人话: 失业的人之后死亡的概率比在职的人高约六成, 男性和年纪不大的人更明显, 头十年最高。把抽烟喝酒的影响扣掉, 升幅少了约四分之一, 这部分自己能管住。先去办失业登记、领失业保险金, 领的期间医保由失业保险代缴。
- 收益: 42 项研究、235 个死亡风险估计、逾 2000 万人合起来算。把年龄等条件的影响扣平之后, 失业者各种原因加起来的死亡风险平均 HR 为 1.63, 比在职的人高约六成。男性高于女性。对处在职业生涯早期和中期的人影响明显, 晚期较小。跟踪的头 10 年风险最高, 之后下降。在把抽烟喝酒这类健康行为也算进去的那部分研究里, 平均 HR 低 24%, 即算出来的升幅少了约四分之一
- 证据等级: A
- 来源: Roelfs DJ, et al. (2011). Losing life and livelihood: a systematic review and meta-analysis of unemployment and all-cause mortality. *Social Science & Medicine*. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.01.005>
- 备注: 这是回头翻人群数据的研究, 分不清因果方向。本来身体差的人也更容易失业。但「把生活习惯那部分影响扣掉后, 效应低 24%」给了可着手的方向。失业能领什么、去哪领、社保怎么续见第 7 节。被辞退该拿多少补偿、别签主动辞职见第 19 节。

4. 亲人死于自杀、意外或凶案的, 别指望硬扛, 主动去找专业帮助

- 成本: 打 12356 不花钱。要看医生, 挂心理门诊是普通门诊的钱。难在自己开口找人。
- 说人话: 配偶死于自杀的人, 五年内被查出精神障碍的概率比一般人高约八成 (男性)、七成 (女性)。和配偶死于其他原因的人比, 也高七成到一倍。这类丧亲的人更容易觉得被人疏远、觉得羞耻。这正是要主动去找人的理由, 别等自己好起来。
- 收益: 丹麦全国档案跟踪 670 万成年人, 时间是 1980 至 2014 年, 合计逾 1.36 亿人年 (所有人被跟踪的年数加总)。因配偶自杀而丧偶的人, 5 年内新查出精神障碍的风险和一般人比, IRR 男性 1.8 (95% CI 1.6–2.0), 即高约八成。女性 1.7 (1.6–1.8), 即高约七成。和因其他死因丧偶的人相比, IRR 男性 1.7 (1.5–1.9)、女性 2.0 (1.9–2.2), 即高七成到一倍。这批人里, 自杀行为、死亡率与需要市政救助的比例也更高。肝硬化、睡眠障碍等身体上的病, 风险同样升高。另有 57 项研究逐项归纳, 不合并算数。因自杀丧亲, 和下面四件事相关。一是伴侣自杀风险升高。二是子女自杀后父母住进精神科的风险升高。三是成年子女自杀后母亲自杀风险升高。四是父母自杀后子女抑郁风险升高。和因其他暴力死亡丧亲的人相比, 因自杀丧亲的人更常说自己被人疏远、觉得羞耻
- 证据等级: A
- 来源: Erlangsen A, et al. (2017). Association Between Spousal Suicide and Mental, Physical, and Social Health Outcomes: A Longitudinal and Nationwide Register-Based Study. *JAMA Psychiatry*. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2017.0226>; Pitman A, et al. (2014). Effects of suicide bereavement on mental health and suicide risk. *The Lancet Psychiatry*. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(14\)70224-X](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(14)70224-X);

Kristensen P 等 (2012). Bereavement and mental health after sudden and violent losses: a review. *Psychiatry*. <https://doi.org/10.1521/psyc.2012.75.1.76> (备注里那份综述)

- 备注：突然的、暴力性的死亡，指的是事故、凶案、灾害。这类死亡之后，创伤后应激障碍、抑郁和哀伤卡住的比例都比病亡后高。恢复也更慢。自己有自杀念头时的处置见第 1 节第 25 条。

5. 丧偶后的头半年，把三餐、睡觉、慢性病的药和复查交给一个固定的人盯着

- 成本：不花钱。找一个具体的人，子女、兄弟姐妹或者朋友都行，让他定期上门或者打电话。难在要开口把这件事托付出去。
- 说人话：丧偶后不到半年，同期死亡的概率比没丧偶的人高约四成。半年以后降到高约一成半。男性高约两成三，女性那一档小到可能只是巧合。这个差不是靠想开点能扛过去的。该做的是把药、饭和复查落到一个具体的人身上，别指望自己记得住。
- 收益：15 项先登记再往后跟踪的研究、2,263,888 人合起来算。丧偶不足 6 个月时死亡 RR 1.41 (95% CI 1.26–1.57)，即同期死亡概率比没丧偶的人高约四成。6 个月以后是 1.14 (1.10–1.18)，降到高约一成半。男性 RR 1.23 (1.18–1.28)，高约两成三。女性 1.04 (1.00–1.08，无统计学意义，即这点差可能只是巧合)。小于 65 岁与 65 岁以上没看出明显差别。另一项分析合并了 123 篇文献、1377 个风险估计、逾 5 亿人。把条件差异扣平后 HR 1.23 (1.19–1.28)，即整体高约两成三。男性还高于女性。男性 1.27 (1.19–1.35)，高两成七。女性 1.15 (1.08–1.22)，高一成五。
- 证据等级：A
- 来源：Moon JR, et al. (2011). Widowhood and mortality: a meta-analysis. *PLoS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0023465>; Shor E, et al. (2012). Widowhood and mortality: a meta-analysis and meta-regression. *Demography*. <https://doi.org/10.1007/s13524-012-0096-x>
- 备注：这是回头翻人群数据的研究，别的因素掺进来去不掉。夫妻的生活方式和疾病本来就相似。但「头半年比之后高得多」这个规律，在两份各自独立的汇总分析里都一样，值得当成一段照看窗口。男性风险更高，也更少开口求助。家里有丧偶老人的，按第 17 节把账户、监护和遗嘱一并理清。找不到这样一个人的（独居、失独、子女也不在了），把这件事交给社区和手机，见本节第 6 条。

6. 没有亲人也没有朋友的，把「盯着你的那个人」换成三样东西：能进你家门的邻居、社区的探访名单、手机里的紧急联络

- 成本：不花钱。难在要主动开口，跟邻居和居委会说一句「我一个人住，家里刚出事」。
- 说人话：没有亲人也没有朋友时，要顾的是两件事：出了事有人发现你，平时按时吃药吃饭。吃药吃饭靠自己，写成清单、上闹钟，别靠记忆。有人发现靠三样：给邻居留一把备用钥匙，去居委会问能不能上探访关爱名单，手机设好紧急联络人、别关机。
- 收益：44,573 名门诊病人，都有动脉粥样硬化血栓的风险或者病史（血管里长斑块、容易被血块堵住的那类毛病）。他们由多国医生登记进 REACH 这个国际项目跟踪，2003 年 12 月至 2004 年 12 月入组，跟踪 4 年。其中 8,594 人 (19%) 独居。独居的人 4 年里各种原因加起来的死亡为 14.1%，同住的是 11.1%。心血管死亡 8.6% 对 6.8%。两项 log-rank $P < 0.01$ ，差别不太可能是碰巧。不同年龄段的差距不一样（交互 $P = 0.03$ ）。45 至 65 岁，独居对同住的死亡为 7.7% 对 5.7%。把别的条件扣平后 HR 1.24 (95% CI 1.01–1.51)，即高约两成四。66 至 80 岁是 13.2% 对 12.3%，HR 1.12 (1.01–1.26)，高约一成。80 岁以上是 24.6% 对 28.4%，HR 0.92 (0.79–1.06)，反而没见升高。民政部等十部门 2022 年意见规定，要开展探访关爱服务。对象是独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等老年人。服务方式为「定期上门入户、电话视频、远程监测」。由乡镇（街道）摸底排查、村（居）民委员会协助，掌握基本信息和「接受探访关爱服务的意愿」并纳入基层网格化管理，也就是按片区分给专人盯着。到 2025 年底「确保特殊困难老年人月探访率达到 100%」，「对失能的特殊困难老年人，每月探访关爱不少于一次」。文件还倡导家庭配置智能呼叫系统、智能电表、健康监测产品、养老监护装置，「一旦监测异常，能够及时预警，并同步向紧急联系人发送提示信息」。服务人员发现紧急问题「应当第一时间协助拨打紧急求助电话」。

- 证据等级：B
- 来源：Udell JA, et al. (2012). Living alone and cardiovascular risk in outpatients at risk of or with atherothrombosis. Archives of Internal Medicine. <https://doi.org/10.1001/archinternmed.2012.2782>; 民政部等十部门 (2022). 关于开展特殊困难老年人探访关爱服务的指导意见 (民发〔2022〕73号). https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-10/13/content_5718017.htm
- 备注：三样东西具体怎么办。一，把备用钥匙或者门锁的临时密码给一个邻居或者物业，跟他说一句「我这几天一个人」。不需要交情，只需要有人知道你在屋里。二，去社区居委会说明自己独居，问能不能上探访关爱的名单。老年人里独居、空巢、失独的是官方明确的服务对象，顺便问本地有没有免费装的智能呼叫器、智能水表这类装置。三，手机设好紧急联络人和医疗急救卡，这几天别静音、别关机。给 B 的原因有两条。一是独居和死亡率的关联来自回头翻人群数据的研究，去不掉「本来身体差、条件差的人更可能独居」这层反过来的解释，原文自己也写这个结果有待确认。二是探访关爱那份文件只覆盖老年人。不满 60 岁的没有对应的专门制度。能指望的是文件里的一条，它要求网格员和社工「及时发现家庭变故、失业、失学等心理危机风险」（见本节第 11 条，要人陪着说话打 12356）。「屋里有人」为什么值钱，看第 13 节第 1 条（按压胸口）。发生在医院外的心脏骤停，79.2% 发生在家里。旁边有人做按压的，活着出院的占 16.1%，没人的只有 3.9%。屋里没人就等于落在低的那一档。另外两件顺手的事。办丧事本身就要跑殡仪馆、社区卫生服务机构、公安、公积金好几个窗口（见第 25 节）。把它排成每天出门一次的固定日程，这几天的外出安排现成就有。热线可以反复打，不是只能打一次（见本节第 11 条，要人陪着说话打 12356）。「一个人住」本身还是个长期风险因素。独居的死亡比值比 1.32，高出约三成，见第 22 节第 9 条（把定期和人见面当健康支出）。但这里只管眼前这几天，长期那笔账另算。

7. 家长去世后，如实告诉孩子、让他参加告别、别送去别处「换个环境」

- 成本：不花钱。难在自己也正难受，还得跟孩子把话说清楚。
- 说人话：18 岁前失去父亲或母亲的孩子，到成年早期死亡的概率比没经历过的孩子高约五成。父母死于意外、自杀的高约八成，死于疾病的高约三成。家里能做的是如实告诉他，让他参加告别，别中断上学，别送去亲戚家换环境。
- 收益：丹麦 1968 至 2008 年、瑞典 1973 至 2006 年出生的全部人口都算进来。再加上芬兰 1987 至 2007 年出生者里抽出的 89.3%。合计逾 730 万人。其中 189,094 人在 18 岁前失去父母。这批孩子各种原因加起来的死亡率，比没丧亲的人高 50%（死亡率比 1.50，95% CI 1.43–1.58，即约 1.5 倍）。父母死于意外、自杀这类非自然原因的是 1.84（1.71–2.00），高约八成。死于疾病等自然原因的是 1.33（1.24–1.41），高约三成。孩子的死因和父母的死因属同一类时最高
- 证据等级：B
- 来源：Li J, et al. (2014). Mortality after parental death in childhood: a nationwide cohort study from three Nordic countries. PLoS Medicine. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001679>
- 备注：跟孩子说的时候别编「出远门了」，监护和抚养的安排要落到书面。给 B 不是因为数字不硬。这是三个国家全体人口的跟踪研究，数字本身够 A 级。给 B 是因为从这个数字到「怎么跟孩子说、要不要参加告别」的具体做法之间，没有直接试验证据。作者也写明，丧亲后亲子关系和孩子生活方式的数据都缺。升高里既有天生体质的成分，也有丧亲留下的长期影响。指定监护人和安排财产见第 17 节。孩子的抚养费 and 上学见第 18 节。

8. 哀伤过了半年还在原地、日子过不下去，去精神科或临床心理科挂号

- 成本：挂号费加治疗费。这类治疗按疗程做，试验里平均 19 周做 16 次。难在要自己迈出去挂这个号。
- 说人话：大约每十个丧亲的成年人里有一个会卡住：半年以上还在持续想念到吃不下饭、上不了班、带不了孩子，人麻木，觉得生活没有意义。这不是不够坚强，它有诊断标准，也有专门的治疗。针对性治疗的有效率 51%，普通心理治疗是 28%，起效也更快。

- 收益：14 项研究合起来算，对象是亲人不是死于暴力、本人也没在精神科就诊的成年人。延长哀伤障碍患病率 9.8% (95% CI 6.8–14.0)，即每 100 个丧亲的成年人里约 10 个。年龄越大比例越高。另有一项研究检验这套诊断标准准不准，找了 291 名丧亲者，在丧亲后 0–6、6–12、12–24 个月分三次访谈。诊断的核心表现是对逝者的强烈想念。还要加上这九项里的至少五项。前五项是情感麻木、震惊、觉得生活没有意义、不信任他人、因这次失去而痛苦。后四项是难以接受、认不清自己该是谁、回避现实、无法继续生活。这些表现要每天都出现，或者严重到干不了事。而且在亲人去世至少 6 个月后仍然存在，还影响着日常生活。还有一项 95 人抽签分两组的试验，做 16 次治疗、平均 19 周。针对复杂哀伤的治疗有效率 51%。普通的人际心理治疗 28% ($P=0.02$ ，差别不太可能是碰巧)。前者起效也更快。需治疗人数 4.3，即平均每治 4.3 个人就多一个好转
- 证据等级：A
- 来源：Lundorff M, et al. (2017). Prevalence of prolonged grief disorder in adult bereavement: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.01.030>; Prigerson HG, et al. (2009). Prolonged grief disorder: Psychometric validation of criteria proposed for DSM-V and ICD-11. *PLoS Medicine*. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000121>; Shear MK, et al. (2005). Treatment of complicated grief: a randomized controlled trial. *JAMA*. <https://doi.org/10.1001/jama.293.21.2601>
- 备注：别自己卡月份。真正的判断是「影响到吃饭、睡觉、上班、带孩子」，对上了就去挂号。科室叫精神科、心理科或临床心理科，公立精神专科医院都有。这个诊断在不同资料里叫复杂哀伤，也叫延长哀伤障碍。不同标准要求持续多久也不一样，有的写 6 个月，有的写 12 个月。9.8% 这个比例来自 14 项做法差异不小的研究，作者也提醒它未必能照搬到别的人群身上。

9. 别一上来就花钱做哀伤咨询，先看自己的哀伤是不是真的卡住了（第 8 条那几条症状）

- 成本：不花钱，反过来省下一笔咨询费。
- 说人话：给所有丧亲的人都安排心理咨询，好处很小，过一阵就看不出来了，因为多数人本来会自己缓过来。但对已经明显适应不了的人，治疗和治别的心理问题一样有效。所以先对照第 8 条（哀伤卡住了去精神科），对上了再花这笔钱。
- 收益：61 项对照研究合起来算。给丧亲的人普遍做心理干预，在治疗刚结束时好处很小，隔一段时间再看就看不出好处了。只招收「已经明显适应不了」的丧亲者的干预，效果和治疗其他心理问题的心理治疗一样好。事先不做筛查的研究结果不好，原因是没做干预的那一组本来也会随时间自己缓过来。另有 14 项抽签分组试验合起来算：对已经出问题的人做的治疗，在治疗后和之后回访时都明显好于对照，隔一段时间效果还在变大。对还没出问题的人普遍做的预防性干预无效。还有一项研究把 205 人从丧偶前一直跟到丧偶后 6、18 个月。这项研究分出五种走向。分别是普通哀伤、长期哀伤、长期抑郁、丧亲期间反而好转、韧性（扛得住）。其中韧性型最常见，普通哀伤型相对少见
- 证据等级：A
- 来源：Currier JM, et al. (2008). The effectiveness of psychotherapeutic interventions for bereaved persons: a comprehensive quantitative review. *Psychological Bulletin*. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.5.648>; Wittouck C, et al. (2011). The prevention and treatment of complicated grief: a meta-analysis. *Clinical Psychology Review*. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.09.005>; Bonanno GA, et al. (2002). Resilience to loss and chronic grief: a prospective study from preloss to 18-months postloss. *Journal of Personality and Social Psychology*. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.83.5.1150>; Stroebe M 等 (2007). Health outcomes of bereavement. *Lancet*. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)61816-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61816-9)（备注里那份综述）
- 备注：意思是「不必人人做」，不是「都别做」。第 4 条（亲人死于自杀、意外或凶案）那类高危丧亲、第 8 条（哀伤卡住了去精神科）那类已经卡住的人，正是有证据支持该做的人。一篇 *Lancet* 综

述的结论也是这样：哀伤不是病，多数人不需要专业干预。该把力气用在高危的人身上。也用在已经出现复杂哀伤、丧亲后抑郁和应激障碍的人身上。

10. 分居离婚之后别断医保、别用酒顶着

- 成本：不花钱。把医保续上，把酒停掉。难在这段时间容易靠酒顶着。
- 说人话：分居或离婚的人早死的概率明显高于还在婚的人，男性和年纪较轻的人升得更多。这不一定是离婚造成的，离婚的人在健康、收入上本来就可能不一样。能自己管住的有两样：别让医保、体检断掉，别靠烟酒顶着。
- 收益：32 项先登记再往后跟踪的研究合起来算，覆盖逾 650 万人、16 万例死亡、逾 75.5 万例离婚、11 个国家。和还在婚的人相比，分居或离婚的成年人早死风险明显升高。男性和年纪较轻的人，升得比女性和年长者明显。作者讨论了四条可能的路径。一是社会选择，本来健康或条件就不一样的人更容易走到离婚。二是资源中断，收入和保障断掉。三是健康行为改变，烟酒作息变差。四是慢性心理压力（长期紧绷）
- 证据等级：A
- 来源：Sbarra DA, et al. (2011). Divorce and Death: A Meta-Analysis and Research Agenda for Clinical, Social, and Health Psychology. Perspectives on Psychological Science. <https://doi.org/10.1177/1745691611414724>
- 备注：原文只说了「明显升高」和分组对比，没给能引用的倍数，所以这里不写具体数字。收益量级按「知道方向、没有可套阈值的降幅」定为中。离婚时的财产、债务与彩礼见第 8 节和第 10 节。孩子的抚养安排见第 18 节。

11. 要人陪着说话打 12356，未成年人和青少年打 12355，要看医生挂心理门诊

- 成本：不花钱。两条热线都免费。心理门诊按普通门诊挂号。
- 说人话：想找个人说话，打 12356，这是全国心理援助热线，免费。未成年人和青少年另有 12355 青少年综合服务平台。要看医生，就挂精神科、心理科或临床心理科的心理门诊。遇到家庭变故、失业、失学，社区网格员和社工本来就该主动发现。
- 收益：国家卫生健康委等 25 部门 2026 年方案要求完善 12356 心理援助热线工作制度。要保证稳定运行、提升接通率。要推动建立省级 12356 信息化平台。要加强与 110 等服务热线的联动机制建设。还要建强用好 12355 青少年综合服务平台，并与 12356 联动协作。到 2030 年的目标有三条。一是 80% 以上的行政村、城市社区设心理咨询室或社会工作室并提供心理服务。二是各级公立精神专科医院、各县（区）至少有 1 所医院提供心理门诊服务。三是各省建成省级 12356 心理援助平台。心理危机干预与心理援助队伍，由精神科医师、心理治疗技师、心理咨询人员、社会工作专业人员和志愿者组成。方案还要求三类人平时就留意、早点发现。这三类人是网格员（社区里按片区负责的工作人员）、社会工作专业人员和志愿者。他们要及时发现家庭变故、失业、失学等心理危机风险（全国，2026 年 3 月印发）
- 证据等级：B
- 来源：国家卫生健康委等 25 部门 (2026). 关于印发健全社会心理服务体系和危机干预机制实施方案的通知（国卫医政发〔2026〕8 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065035.htm
- 备注：给 B 是因为村和社区的咨询室、县级的心理门诊都是 2030 年才要建成的目标，不是现在各地都有。12356 和 12355 则是现在就能打的。12356 的开通时间和每天接听多长时间见第 1 节第 25 条。心理咨询和心理治疗不是一回事。下诊断、开药得由精神科医师来，治疗要在有资质的医疗机构做。市面上按小时收费的「疗愈」「灵性咨询」不在这个体系里。

12. 变故后的头三个月，凡是不可逆的大决定一律往后推

- 成本：不花钱，只是把决定往后推，可能因此错过某些机会。难在当时会觉得机会不等人。

- 说人话：这段时间你对各种「机会」的判断力最差。说能联系逝者的、说能帮你把钱翻回来的、劝你辞职去外地重新开始的、拉你合伙的，都会找上来。金额超过一个月收入、或者反悔代价很大的事，一律推后三个月。先讲给一个跟这件事没利益关系的人听，别当天拍板。
- 收益：避免在刚受打击、判断力最差的那段时间，做出反悔不了的财产处置。这类事包括卖房、辞职、把抚恤金或赔偿款一次性投出去、仓促再婚、替人担保。这类决定的金额通常在数万元到一套房子这个量级，收益因此定为中。官方文件同样把「家庭变故、失业、失学」列为社区要主动排查的心理危机风险，这段时间的状态本来就被当成需要外人搭把手的状态
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，无直接文献；「家庭变故、失业、失学」作为心理危机风险的表述见国家卫生健康委等 25 部门 (2026). 健全社会心理服务体系和危机干预机制实施方案 (国卫医政发〔2026〕8 号). https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065035.htm
- 备注：身边没有这样一个没利益关系的人，就打 12356 讲一遍（见本节第 11 条，要人陪着说话打 12356），或者自己写下来隔三天再读一遍。「三个月」是作者自己划的线，没有文献支持这个具体时长，所以记 C 级。针对丧亲者和老人的常见骗局见第 17 节（投资养老、以房养老）和第 6 节（算命）。担保和借条的坑见第 8 节。有几笔钱要主动去办，不在「往后推」之列：公积金余额、社保待遇、工亡三笔钱，见第 25 节和第 19 节。

13. 别拿死当还债的办法：两年内的寿险不赔，工伤不认，债照样先从遗产里扣

- 成本：不花钱，只是把这笔账算清。
- 说人话：寿险合同两年内自杀的不赔，只退保单里能退的那点钱。工伤也不认，工亡的三笔钱一分没有。欠的债先在你留下的遗产里扣，家里人只拿剩下的。他们还要承受本节第 4 条（因自杀或暴力死亡丧亲）说的那份健康代价。
- 收益：保险法第四十四条管的是以被保险人死亡为给付保险金条件的合同。从合同成立或者合同效力恢复之日起算，二年内被保险人自杀的，保险人不承担给付保险金的责任。被保险人自杀时为无民事行为能力人的，也就是法律上不能为自己行为负责的人，不在此列。这种情况下保险公司应当按照合同约定退还保险单的现金价值，即只退保单里能退的那点钱，不赔保额。寿险保额通常在数十万元级，收益因此定为大。工伤保险条例第十六条第三项规定：自残或者自杀的，不得认定为工伤或者视同工伤。第三十九条那三笔工亡待遇随之全部落空。一是丧葬补助金，按当地上一年职工月平均工资发 6 个月。二是供养亲属抚恤金。三是一次性工亡补助金，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍。民法典第一千一百五十九条规定：分割遗产应当清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务，即先拿遗产还税和债，剩下的才分。第一千一百六十一条规定：继承人以所得遗产实际价值为限清偿，也就是只用继承到的那部分还、不用自己再掏，放弃继承的可以不负清偿责任
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2015 修正). 中华人民共和国保险法第四十四条. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7c4060811>；国务院 (2010 修订). 工伤保险条例（国务院令 第 586 号）第十六条、第三十九条. https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1778064.htm；全国人大 (2020). 中华人民共和国民法典第一千一百五十九条、第一千一百六十一条. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808081729d1efe01729d50b5c500bf>
- 备注：这里只算钱这一笔账。本节和第 1 节的其他条目说的是别走到这一步。保险法第四十四条管的只是前两年，写出来是为了把条文说全，不是在给时间表。家人的健康代价见本节第 4 条（配偶死于自杀者 5 年内新发精神障碍风险高七到八成）。念头冒出来时怎么办见第 1 节第 25、32 条，救回来之后的后遗症见第 1 节第 33 条。工亡三笔钱的标准见第 19 节第 15 条。遗产和债务的具体手续见第 25 节第 9 条（逐个去取公积金和社保待遇）

30. 上学以后的孩子

第 20 节讲的是孩子刚出生那一年。第 18 节算的是养孩子要花多少钱、多少时间。中间 3 到 18 岁这十几年，写在这一节。分龄管屏幕那一条从 0 岁写起，因为官方的分档就是 0~3 岁、3~6 岁、中小学三档，拆开写反而不好用。本节回答的是：「别耽误学习」和「身体」撞在一起的时候，哪些事不能等。这些事有时间窗口，过了就补不回来。学业该不该那么卷，本节不讨论，只给窗口和数字。

前八条、第 12 条（散瞳验光）、第 13 条（窝沟封闭）和第 15 到 18 条，算的是死亡和身体、心理上真落下的损害。其中第 16、17 条讲家里怎么管孩子：不打不骂，去上教具体做法的家长课。第 18 条讲别把孩子送进封闭管理的戒网瘾学校。第 9 条（不买「治愈近视」的产品）算钱。第 10 条（睡眠作业体育排名的明文规定）、第 11 条（休学保留学籍）和第 14 条（孩子爱打游戏）算时间。溺水、交通、头盔、HPV 疫苗见第 1 节。婴幼儿见第 20 节。孩子被骗和游戏充值见第 5 节。未成年人自己别踩的红线见第 9 节。急症怎么认、怎么叫车见第 13 节。家长去世后的孩子见第 29 节。这些都不在本节重复。

1. 孩子说突然剧痛、而且越来越重，立刻去医院，不要让他忍到放学

- 成本：不花钱。请半天假，带孩子去挂急诊。
- 说人话：有些病是按小时算的。男孩突然一侧阴囊剧痛，是睾丸扭转，也就是睾丸连着的那根血管拧住了，血供断了。6 小时内处理，睾丸保住的比例 97.2%。拖到 19 至 24 小时，只剩 42.5%。这种痛等不到放学，也等不到考完。
- 收益：按规矩把 30 组病例报告、2116 例睾丸扭转患者找齐，合起来看。其中 1283 例是按 6 小时一档统计的。从开始痛算起，0 至 6 小时睾丸保住的比例 97.2%。7 至 12 小时 79.3%。13 至 18 小时 61.3%。19 至 24 小时 42.5%。25 至 48 小时 24.4%。超过 48 小时 7.4%。合并成大段看，12 小时内 90.4%，13 至 24 小时 54.0%，超过 24 小时 18.1%。作者的结论是，能保住的时间可以比通常说的 6 至 8 小时更长。所以就算已经痛了很久，也还是要去处理，不要因为「反正晚了」就不去
- 证据等级：A
- 来源：Mellick LB, et al. (2019). A Systematic Review of Testicle Survival Time After a Torsion Event. *Pediatric Emergency Care*. <https://doi.org/10.1097/PEC.0000000000001287>
- 备注：提前跟男孩说一句：下面要是突然剧痛，马上讲，不用不好意思。睾丸扭转多发于青春期的男孩，不少人因为难以启齿就硬忍。同样按小时算的还有急性阑尾炎（拖久了会穿孔）、糖尿病酮症酸中毒、脑膜炎。这几种本节没有逐条核实过「拖几小时坏多少」。它们共同的信号是：突然发作，一直加重，和以往任何一次都不一样。急症怎么认、怎么叫车见第 13 节。

2. 该做的治疗别为了「等考完」往后拖，有些窗口跟着骨龄走，不跟着考试安排走

- 成本：不花钱，要定的只是早做还是晚做。请假和复诊要占时间，治疗本身的花费另算。难在支具要求每天至少戴 18 小时，孩子得一直忍着。
- 说人话：脊柱侧弯是脊柱往侧面弯。支具是一件硬壳背心，穿在身上把脊柱撑住。骨头还在长的时候戴，75% 的孩子没弯到要开刀的程度，只观察不戴的只有 42%。能戴的时间跟着骨头长完走，不跟着中考高考走，等考完往往只能开刀。
- 收益：多家医院一起做的试验，找了 242 例够条件戴支具的青少年特发性脊柱侧弯患者。其中 116 例抽签分组，126 例自己选戴不戴。成败事先定好怎么算：弯度长到 50 度以上算治疗失败，骨头长完时还没到这个度数算治疗成功。按最初分到哪一组来算，不管后来有没有真戴够。抽签戴支具组成功率 75%，抽签只观察组 42% (OR 4.11, 95% CI 1.85–9.16)，成功的机会约为只观察的 4 倍。把抽签的和自己选的两拨人合起来算，是 72% 对 48%（把两拨人本来的差别扣平后 OR 1.93, 1.08–3.46, 仍约 1.9 倍）。每天戴的小时数越多，成功率越高 ($P < 0.001$ ，这个关系不太可能是碰巧)。试验因为支具确实有效，提前停掉了
- 证据等级：A
- 来源：Weinstein SL, et al. (2013). Effects of bracing in adolescents with idiopathic scoliosis. *New England Journal of Medicine*. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1307337>